جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : يسريه سليمان فهمى مصطفى
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** مصر القديمه **العنوان :** القاهره
رقم البطاقة : 25204190100528 **رقم التليفون :** 01115869858 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 19-04-1952 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: يسريه سليمان فهمي مصطفى
National ID: 25204190100528

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Patient's Name:	**Yusriya Suleiman Fahmy Mustafa**
Date:	**2026-08-16**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISLICE CT EXAMINATIUON OF THE CHEST ,ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST ADMINISTRATION REVEALED:-

- Enlarged thyroid gland with calcified foci noted inside and the largest one measures about 16mm.
- Non-homogenous density in the left breast.
- Left axillary lymph nodes are seen with loss of their hilar fat contents and the largest one measures about 12 mm in diameter.
- Hyperinflated both lungs.
- Linear atelectatic bands are seen scattering in both lung fields.
- Enhancing pretracheal lymph nodes are seen and globally measure about 82x3.2mm in dimensions.
- No sizable abnormally-enhancing pulmonary nodules ,other patchy areas of consolidations or foci of calcifications noted.
- No other sizable abnormally-enhancing mediastinal or hilar lymph nodes seen.
- Patent central airways.
- Minimal pericardial effusion.
- No pleural effusions.
- **Border line size of the heart with normal CT of its big vessels.**
- **Normal bones of the thoracic cage apart from** a tiny osteosclerotic bony lesions seen in DV10 and **degeneration of DV8-DV11 discs.**
- Average sized liver, measuring about 12.2cm, showing a homogenous parenchymal attenuation and enhancement pattern.
- No sizable abnormally-enhancing focal lesions or dilated biliary radicles.
- Patent PV.
- Average sized spleen,measuring about 10.1 cm. No focal lesions seen inside.
- Normal CT appearance of the pancreas, functioning both kidneys, both suprarenal glands, aorta and IVC.
- No sizable abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No intra-vesical stones,solid masses,wall thickening or diverticulosis seen.
- Calcified foci are seen in the uterus with the largest one measures about 15mm.
- The rest of the pelvic structures are unremarkable.

IMPRESSIONS:

- **Multinodular thyroid goitre.**
- **Non-homogenous density of the left breast with left axillary and pretracheal lymphadenopathy and a tiny osteosclerotic bony lesion in DV10,likely to be metastases.**
- **Linear atelectatic bands scattering in both lung fields.**
- **Calcified foci in the uterus ,likely to be calcified fibroids.**

Dr.Hanan Alahwel

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

10/05/2026

MDT FORM

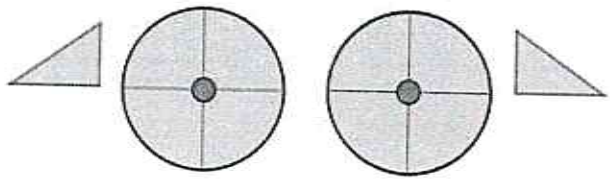
Name:	Yousrea سليمان Fahmy مصطفي	**MRN:**	12384
Age:	74 Y	**ID:**	25204190100528
Menopausal Sta	post	**Phone:**	01003630769
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:	Cardiac -Mental retardation -Multiple nodular goitre	**Reason Of MDT:**	new case

Clinical Data:

BX: idc gii

ER: 8/8 **PR:** 0/8 **HER2:** - **KI67:** 10

R L



TNM

Sonomammography:
BSM 5/2026 : IT bREAST mALIGNANT LOOKING MASS birad 5

Mets Workup:
ECHO :EF :48 % IN April 2026
CT CAP : Lt axillary and pretracheal lymph nodes and tiny osteosclerotic bony lesion in DV 10 likely mets

History:

Recommendations:
AI due to mental and physical condition of the patient (PS:3)

MDT Outcome & Plan
Start AI for 3 months then evaluate

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
nermean mostafa	moh nabaraway				

جوستاف روسي

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

البنك المصرية لصحة مصر

10/05/2026

MDT FORM

Name:	Yousrea سليمان Fahmy مصطفي	**MRN:**	12384
Age:	74 Y	**ID:**	25204190100528
Menopausal Sta	post	**Phone:**	01003630769
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:	Cardiac -Mental retardation -Multiple nodular goitre	**Reason Of MDT:**	new case

Clinical Data:

BX: idc gii

ER: 8/8 **PR:** 0/8 **HER2:** - **KI67:** 10

Sonomammography:
BSM 5/2026 : IT bREAST mALIGNANT LOOKING MASS birad 5

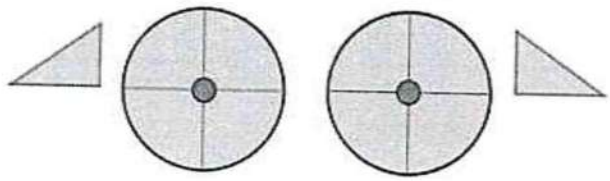
Mets Workup:
ECHO :EF :48 % IN April 2026
CT CAP : Lt axillary and pretracheal lymph nodes and tiny osteosclerotic bony lesion in DV 10 likely mets

History:

Recommendations:
AI due to mental and physical condition of the patient (PS:3)

MDT Outcome & Plan
Start AI for 3 months then evaluate

R L



T N M

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
nermean mostafa	moh nabaraway				

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]



National ID – Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID – Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

معامل الخليـة
لتحاليل الأنسجة والأورام

Patient Name	يسريه سليمان فهمي	**Code Number**	**YK 26015373**
Sex/Age	**Female 74 Y 0 M 0 D**	**Patient ID**	**93327**
Registered Date	**19/5/2026 04:06:45 PM**	**Referred By Dr.**	محمد السيد عبد اللاه
Validation Date	**04/6/2026 04:27:50 PM**	**Branch**	حلوان
Reporting Date	**07/6/2026 09:31:07 PM**		

Clinical Diagnosis: Left Breast Mass
Nature of the specimen: U/S Guided TCNB

Pathology Report

Gross Picture

Multiple fragmented grey, white tissue cores measured 1 cm in total length, totally submitted.

Microscopic Picture

Sections examined revealed breast tissue core showed minimal discohesive anaplastic cells having pleomorphic bizarre nuclei. They were arranged in cords and Indian files. The stroma was desmoplastic.

Diagnosis

Left Breast Mass, U/S Guided TCNB:
Minimally Represented Lobular Carcinoma.
For Immune Confirmation.

P.O

Number of slides enclosed: 2

Diagnosed by

Consultant Pathologists
Dr. Ahmed Soliman, MD
Dr. Dalia AbouelFadl, MD

Scan Me

الفرع الرئيسي الدقي : ٢٠ شارع التحرير أمام مترو البحوث - الدقي - الدور الأول
م: ٠١١١٢٤٤٣٣٣ - ٠١١١١٥٥٧١١٧ - ت: ٠٢٣٣٣٥٣٠٧٣

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

NAME : YOSRIA SOLIMAN DATE : 18 MAY 2026
REFERRED BY DR. MOHAMAD EL SAYED

Bilateral Soft Tissue Mammography With Complementary Ultrasound Reveals

- *Both breasts display homogenous fatty parenchyma (ACR 1)*
- *An ill defined irregular shaped mass is seen at the left breast retro-areolar infiltrating the surrounding parenchyma, corresponding to US detected ill defined irregular shaped speculated outline hypo echoic solid mass seen at retro-areolar of the left breast measuring 2.6x2cm in diameters.*
- *No right breast solid or cystic masses*
- *Normal skin thickness and contour*
- *Normal nipple/areola complexes*
- *Bilateral benign looking axillary lymph nodes of preserved fatty hilae.*

CONCLUSION:

- *Left breast malignant looking mass BIRADS 5 for biopsy*

- ***N.B.*** The American Cancer Society recommends baseline mammography for women's above 35 years, screening mammography for those above 40 years of age every 2 years and for those above 50 years of age every 1 year.

MUCH OBLIGED YOURS,
Dr. Ahmad Mokhtar, MSc FEBR.